

如果您正在考虑接受盆腔器官脱垂（pelvic organ prolapse）手术，需要与医生共同做出几项选择。通常没有唯一“正确”的答案——最佳方案取决于您的解剖结构、健康状况以及您最看重的因素。本页梳理了主要决策，帮助您进行知情对话。

主要决策

- **修复还是封闭**——重建支撑（重建性手术）并保留阴道功能，或关闭阴道（阴道封闭术，colpocleisis），适用于不打算进行阴道性交的患者。
- **手术路径**——经阴道，或经腹（腹腔镜/机器人手术）。
- **子宫的处理**——切除子宫（子宫切除术），或保留子宫并行悬吊术（子宫保留悬吊术，hysteropexy）。
- **支撑材料**——自体组织（native repair）、生物补片，或合成补片（如骶骨固定术中使用的腹腔补片）。
- **漏尿问题**——是否同时加做抗漏尿手术（见下文）。

关于隐匿性漏尿

有时较大的脱垂会掩盖压力性尿失禁，脱垂修复后漏尿才显现（“隐匿性”压力性尿失禁，occult SUI）。您的医疗团队可能会对此进行测试，并讨论是否同期加做吊带手术，还是观察等待。

名词解释

重建性手术

重建盆底支撑并保留阴道功能。

闭合性手术

关闭阴道（阴道封闭术）——耐久性好，但无法进行阴道性交。

子宫保留悬吊术

保留子宫的悬吊固定手术。

自体组织修复

仅使用自身组织，不使用补片的修复方式。

隐匿性压力性尿失禁

脱垂修复后才出现的隐匿性漏尿。

复发

脱垂在术后随时间再次出现的可能性。

如何做出选择？ 根据您的优先考虑因素来匹配方案——耐久性、恢复时间、是否保留子宫、性生活需求，以及您对补片的态度。您的医生会根据解剖结构和健康状况给出建议；"最佳"方案是在充分沟通后最符合您目标的那个。

术前需向医生咨询的问题

- 您推荐我做哪种**手术**，原因是什么？
- **经阴道还是经腹路径**——两种方式的恢复过程有何不同？
- 我是否可以（或应该）**保留子宫**？
- 将使用**自体组织、补片还是生物材料**——各有哪些风险？
- 我现在是否需要同期做**抗漏尿**手术，还是以后再考虑？
- **复发的**概率是多少，如果复发怎么办？

其他注意事项

- 如果您希望避免或推迟手术，**子宫托（pessary）**始终是非手术替代方案。
- 控制体重、改善便秘、治疗慢性咳嗽，以及（绝经后）使用阴道雌激素，均有助于提高手术效果。

术前准备

- 完成所有**术前检查**，并带上完整的用药清单。
- 计划**戒烟**，并安排好术后的家庭护理。
- 了解一般恢复原则：术后约6周内避免重体力活动和性生活。

如有以下情况请在术前告知您的医疗团队：

- 正在服用**抗凝药物**或有出血倾向
- 目前存在尿路或阴道**感染**
- 出现新发**盆腔疼痛、出血，或脱出处有不愈合的溃疡**

需要记住的三件事

1. 脱垂手术涉及多项选择——修复还是封闭、手术路径、是否保留子宫、支撑材料，以及是否处理隐匿性漏尿。
2. 很少有唯一正确的答案；最佳方案需结合您的解剖条件和个人优先考虑因素。
3. 提出关键问题，并记住子宫托始终是非手术替代选择。